

الناسور المستقيمي الإحليلي هو اتصال غير طبيعي (نفق صغير) بين المستقيم (قناة الشرج) والإحليل (مجرى البول). قد يسمح للبول بالدخول إلى المستقيم وللغاز أو البراز بالدخول إلى مجرى البول، مما يؤدي إلى عدوى متكررة. تُسبب هذه الحالة ضيقاً، غير أنها قابلة للعلاج — في الغالب بمنهج مُخطّط ومتدرّج.

عن هذه الحالة

تشمل الأعراض الشائعة خروج غاز أو براز في البول (فقاعات عند التبول، أو بول عكر ذو رائحة كريهة)، وتسرب البول من المستقيم، وعدوى متكررة في المسالك البولية، وانزعاج حوضي. هذه مشكلة تشريحية لها حلٌ تشريحي — ولا علاقة لها بأي تصرف من جانبك.

الأسباب

معظم حالات الناسور المستقيمي الإحليلي ناجمة عن مضاعفات علاج سرطان البروستاتا — الجراحة (استئصال البروستاتا)، أو العلاج الإشعاعي، أو الإجراءات التحليلية (كالتجميد أو HIFU) — أو عن جراحات المستقيم. وفي حالات أقل، تنشأ نتيجة إصابة أو عدوى أو مرض التهاب الأمعاء. الناسور الناجم عن الإشعاع أصعب في الشفاء.

تعلم المصطلحات

الناسور

نفق غير طبيعي يصل بين عضوين.

المستقيمي الإحليلي

يصف الاتصال بين المستقيم والإحليل.

Pneumaturia

خروج غاز أو فقاعات مع البول.

Fecaluria

وجود مادة برازية في البول.

تحويل المسار

تغيير مؤقت لمسار البول و/أو البراز للسماح بالشفاء.

فغر القولون (Colostomy)

فتحة مؤقتة للبراز يمكن عكسها لاحقاً.

رفرف عضلة Gracilis

رفرف عضلي من الفخذ يُستخدم غالباً لتعزيز الإصلاح.

لماذا قد أحتاج إلى فغرة أو قسطرة مؤقتة أولاً؟ تحويل البول (عبر قسطرة أو أنبوب) وأحياناً البراز (بفغر قولون مؤقت) يُخفّف الضغط عن المنطقة، ويُسيطر على العدوى، ويُريح الأنسجة الملتهبة — مما يهيئ أفضل الظروف لنجاح الإصلاح. التحويل في الغالب مؤقت ويُعكس بعد الشفاء.

كيف تُشخّص

- تنظير المثانة والإحليل (cystoscopy) وتنظير المستقيم
- اختبارات الصبغة والتصوير لتحديد حجم الناسور وموقعه
- مراجعة التاريخ المرضي (علاج البروستاتا، الإشعاع) وجودة الأنسجة

كيف تُعالج

- 1 الإراحة وتحويل المسار — قسطرة (وأحياناً فغر قولون مؤقت) للسيطرة على الأعراض وإتاحة وقت لتعافي الأنسجة.
- 2 الإصلاح الجراحي — غالباً عبر المنطقة بين كيس الصفن والشرج (العجان)، مع إغلاق الناسور طبقةً طبقة.
- 3 الرفراف العضلي — وضع عضلة سليمة (غالباً رفراف Gracilis من الفخذ) بين طبقات الإصلاح، لا سيما بعد الإشعاع.
- 4 العكس — تُعكس الفغرات المؤقتة لاحقاً بعد التأكد من الشفاء.

معلومات مفيدة

- التوقيت مهم — ينتظر الجراحون عادةً حتى تهدأ الالتهابات قبل الإصلاح.
- الناسور الصغير غير المُشعّع قد يُغلق أحياناً بالقسطرة وحدها.
- التغذية الجيدة والإقلاع عن التدخين يُساعدان في الشفاء.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة أو شعور شديد بالتعب (علامات عدوى خطيرة)
- ألم حوضي أو مستقيمي شديد
- عدم القدرة على التبول، أو نزيف غزير

ثلاثة أمور تُذكرها

1. يربط الناسور المستقيمي الإحليلي المستقيمي بالإحليل، مُسبباً خروج غاز أو براز مع البول وعدوى متكررة — في الغالب بعد علاج سرطان البروستاتا.
2. العلاج متدرّج: تحويل المسار وإراحة الأنسجة أولاً، ثم الإصلاح الجراحي (غالباً برفراف عضلي خاصةً بعد الإشعاع)، ثم عكس الفغرات المؤقتة.
3. الحالة قابلة للإصلاح. اطلب الرعاية فوراً عند الحمى أو الألم الشديد أو عدم القدرة على التبول.